失语症人群家庭会话和康复会话中的纠错序列研究

杨信信,马　文

摘　要:失语症患者常因理解表达欠佳出现言语错误。在会话中,会话能力健全的一方常通过一系列修正措施对问题话语进行修正。本文通过会话分析研究方法考查了康复会话与家庭会话两种场景中言语错误的修正方式——纠错,研究发现言语康复师与家属对会话中的错误处理在位置和方式上有很大差别。在医院场景中,康复师较少直接修改会话错误,而是通过多话轮纠错序列引导患者给出修正结果;在家庭环境中,会话伙伴的纠错序列有三种:1)最小后扩展纠错序列;2)内扩展纠错序列;3)多话轮纠错序列。其中前两种序列结构较为普遍,多话轮纠错较少。另外,与康复会话中的多话轮纠错序列不同,家庭场景的纠错序列相对较短,形式多样,伴有非严肃话语,且不注重修正结果。本研究揭示了言语康复师和家属如何处理与失语症患者会话中的问题,对失语症患者的日常生活及康复训练有重要启示意义。

关键词:修正;纠错;失语症;家属和言语康复师

中图分类号:H030　　**文献标识码**:A　　**文章编号**:1000-5544(2025)02-0001-08

Abstract: Conversations involving people with aphasia often contain speech errors due to their limited linguistic abilities. Problematic talk is regularly repaired by parties with intact linguisitic abilities. Adopting conversation analysis, this study examines a particular way of repair (i. e., correction) in both therapeutic interactions and family conversations. The research reveals significant differences in how speech errors are addressed by Speech Language Therapists (SLTs) and family members in terms of its locations and ways of correction. In therapy sessions, SLTs are seen eliciting patients to correct themselves through multi-turn correction sequences rather than directly correct their speech errors. Within the family settings, three types of correction sequences are found: 1) Minimal post-expansion correction sequence, 2) Insert-sequence correction, and 3) Multi-turn correction sequence. The first two sequence structures are more common, while multi-turn correction sequence is less frequent. Unlike multi-turn correction sequences in therapy settings, correction sequences in family settings are relatively shorter, diverse in form, may involve non-serious speech, and do not prioritize the correction outcome. This study sheds light on how SLTs and family members address communication issues in conversations invovling people with aphasia, offering insights for the daily lives and rehabilitation training of people with aphasia.

Key words: repair; correction; aphasia; family memebers and SLTs

DOI:10.16362/j.cnki.cn61-1023/h.2025.02.005

1. 引言

会话修正(conversational repair)是为解决会话中因听力、理解或表达问题而采取的行为,纠错(correction)则是其中一种形式(Schegloff *et al.* 1977:364)。汉语修正研究已对修正、阻碍源及修正的发起完成过程进行了详细全面的概述(马文、高迎 2018:42;谭淑文、马文 2022:16)。修正可以由自我或他人发起,也可以由自我或他人完成。自我修正发起和完成一般在说话者话轮内或话轮转换处完成,自我修正也可以经过一轮他人发起修正后在第三话轮(third turn)完成。他人修正一般在下一个话轮(next turn)或者多次自我修正失败若干个话轮后完成。

修正及阻碍源也在失语症会话中得到深入研究。失语症会话中常见阻碍源包括找词困难、错语和失语法。患者通常通过小品词、连接词或话语中断等方式发起自我修正(Laakso & Sorjonen 2010:1159),会话对象则通过重新设计问题、忽略阻碍源、理解核对或提供目标词汇来协助修正(Beeke *et al.* 2020:940; Wilkinson *et al.* 2003:67)。另外有部分研究对比了不同场景(医院/家庭)下失语症会话的修正结构。Lubinsk *et al.* (1980) 最先提出并考证了失语症会话在医院和家庭场景下的不同。他们发现在家庭场景下的会话序列相较医院场景比较冗长,失语症家属通常使用“猜测序列”(hint and guess)实施修正,但言语康复师通常“忽略”(gloss over)患者阻碍源话论。Lesser & Algar (1995: 81-82) 也发现家属与患者的会话序列相较康复师与患者会话简短,但不同

中国知网 https://www.cnki.net

于 Lubinski 等人的发现,康复师一般会对患者话轮的阻碍源进行修正。Laakso (2015: 280)对比了失语症患者在家庭场景和医院场景下的找词(修正发起的一种),发现家庭场景中的找词完成速度较快,康复师与患者的找词序列在医院场景中则较长,康复师一般不直接给出目标词汇,而是通过提示让患者自我修正。总体而言,家庭场景中修正结构较复杂,修正序列较短,他人修正更直接,多以单词改错为主;相反,在医院场景中,康复师修正相对隐晦,且通常以句子(如,理解核对)为主,修正序列较长。总体而言,国外对于失语症会话中的修正研究相当全面,且研究成果已运用到失语症的评估干预中(Lock *et al.* 2001:26;Wilkinson 2014:220)。国内对于失语症会话的研究相对单薄,目前仅有一例研究讨论了康复师如何应对会话中的阻碍源(谭淑文、马文 2022:22),而且国内失语症的评估方式单一,干预效果有限,因此失语症研究亟待新角度和新方法。

笔者于 2021 年在山东某市三甲医院录制了 4 名失语症患者(2 名中度,2 名重度)在康复科室与家庭场景中的会话。4 名患者病程均 6 个月以上且语言能力稳定 (Goodglass & Kaplan 1983:47)。本研究获得了相关伦理审查批准,并取得了患者、家属及康复师的知情同意。研究采用会话分析研究方法(Jefferson 2004: 13-17),对 340 分钟语料进行转写分析,聚焦语言错误这一主要阻碍源,探究康复师和家属处理会话错误的序列结构。

本文将分三个部分展开讨论:首先,展示家庭场景与康复场景中纠错序列的不同结构;其次,分析造成这些结构差异的潜在原因;最后,探讨纠错序列的不同形式对失语症患者日常沟通和康复训练的启示。

2. 失语症会话中的纠错序列

2.1 言语康复师与失语症患者会话中的纠错序列

在语料收集过程中,由于不同场景下会话时长存在差异,为了控制变量,本文选取了 4 位患者(匿名)分别在康复科室和家庭场景下的会话样本。具体而言,每位患者在每个场景中各截取会话开始后 15 分钟至 25 分钟的 10 分钟片段(即 15:00 分钟至 25:00 分钟区间)。随后,统计出当阻碍源为会话错误时的修正详情。表 1 为康复场景中的会话错误及其处理详情,其中字母 T 代表康复师,P 代表患者。

表 1. 康复场景中的纠错序列

患者	失语程度	会话错误类型(次数)	纠错发起人(次数)	纠错完成人(次数)
A	重度	语音(4);语义(1)	T (90)	T(4);P(1)
B	重度	语音(4)	T (117)	T(4);P(0)
C	中度	语义(2);语法(4)	T (73)	T(5);P(1)
D	中度	语音(2);语义(2);语法(3)	T (81)	T(4);P(3)

表 1 表明,康复师对中度患者的会话错误处理方式较多样,而对重度患者更注重语音练习,这可能反映了康复训练的不同侧重点。康复师倾向通过领读练习重度患者发音,而对中度患者则兼顾语法、句意和发音训练。总体上,纠错多由康复师发起并完成,且对重度患者的纠错发起频率更高。笔者从重度和中度失语康复会话中选取两个典型纠错序列,详细分析康复师与患者会话中的错误及其处理,重点关注纠错序列结构、话轮位置及纠错方式。

语料 1　电视屏幕

	001	Ta:	这是一台什么呢?
	002	A:	/qi/ /qiaojiant/
	003	Ta:	它是干什么的你知道吧
→	004	A:	/ding/ 警车
			5-10 行省略
	011	Ta:	它是电:
→	012	A:	电壶
			13-16 行省略
	017	Ta:	它是看:电视节目的
	018	A:	哦
	019	Ta:	那它是什么东西呢
	020	A:	看呃:
	021	Ta:	它是看电视(.)节目的
→→	030	Ta:	电视
	031	A:	shi
			32-81 行 省略
	082	Ta:	哈? 这是看电视. 这是一台电视. 机
	083	A:	啊
	084	Ta:	哎. 电视机
→	085	A:	/shi/
	086	Ta:	电视机
→	087	A:	/gan/视机
	088	Ta:	电. d i an 电
	089	A:	/kan/
	090	Ta:	你看啊,我给你点发音
			91-116 行省略
	117	T:	D YI An DIAN
→→	118	A:	D YI An DIAN
	119	Ta:	DIAN SHI
	120	A:	啊
	121	Ta:	说呀. 不是啊. 是说哈
	122	A:	YI AN
	123	Ta:	电视
→	124	A:	D-DAN ((长呼气))
	125	T:	电视,你是不觉得挺难啊

中国知网　https://www.cnki.net

语料 1 节选自康复师与重度失语症患者 A 命名康复训练片段,总选段时长约 4 分 30 秒,总话轮 125 个,纠错话轮 57 个,占总话轮 45.6%。整个序列包括 2 个阻碍源:1)警车(第 4 行);2)gan 视机(85、87 行)。2 次修正结果均由康复师给出(30、125 行)。在康复训练过程中,康复师指着电视问患者“这是一台什么”,患者第 2 行给出回应,但回应属于错语(Laakso & Sorjonen 2010:1158),康复师在第 3 行发起纠错,患者第 4 行给出了答案“警车”,属于语义错误,经过 3 次修正发起,患者没有给出正确回应,康复师第 11 行使用部分语法结构(Designed Incomplete Utterances, DIUs)(Koshik 2002:277)继续引发患者自我纠错,但由于患者言语障碍,12 行又出现语义错误“电壶”,康复师仍没给出目标词汇,继续发起修正引导患者找出正确答案。值得注意的是在纠错发起中,康复师把正确答案嵌入(embedded correction)(17、21 行)到了纠错发起中(Oelschlaeger & Damico 2003:221)。30 行康复师提供了目标词汇“电视”,本轮纠错结束。32-81 行省略 26 次康复师试图引发患者讲出电视,最终 83 行康复师给出电视的发音。接下来患者在重复修正结果时,出现语音错误(85、87 行),康复师在 119 行给出正确发音。患者(120 行)通过最小应答“啊”结束序列(Schegloff 2007:47),康复师继续扩展序列要求患者讲出正确发音,经过 1 轮示范(123 行)后,患者再次发错音(124 行),并长叹气,康复师重复给出正确发音(125 行),并对患者表现做解释(account)“是不是挺难啊”(Bolden *et al.* 2022:215)。

语料 2 选自失语中度患者 D 与其康复师会话片段,总选段时长约 2 分钟,总话轮 56 个,纠错话轮 17 个,占总话轮 19.6%。整个序列包括 3 种阻碍源(单箭头指示):1)理解错误(4、6、8 行);2)语法错误(21、31、42、47、51 行);3)发音错误(15、17、19、31 行)。修正结果(双箭头指示处)均由康复师给出(16、18、32、52 行)。

语料 2　老王修理汽车

	001	Td:	这一个. 先读一遍
	002	D:	老王. 汽车. 修理
	003	Td:	啊,把它组成一句话
	004	D:	他>去了< 海边
	005	Td	不对
	006	D:	(1.5) >海<边
	007	Td:	慢一些 [慢一些
	008	D:	[海边
	009	Td:	这里没有海边了 你看好哈 看好再重新读一遍
	010		(2.2)
	011	D:	汽车
	012	Td:	汽车
	013	D:	老王
	014	Td:	老王
→	015	D:	/tou/ lì
→→	016	Td:	xīu lǐ
→	017	D:	/tou/ lì
→→	018	Td:	xīu lǐ
→	019	D:	/tou/ lì
	020	Td:	啊好,把它组成一句话
→	021	D:	(1.1)老王(.)汽车
	022	Td:	把它组成一句通顺的话
	023	D:	老王
	024	Td:	啊老王
	025	D:	(7.0)
	026	Td:	怎么排列. 老王:
	028	D:	老王
	029	Td:	嗯
	030	(2.0)	
→	031	D:	汽车海边(.)/tou/ lì
→→	032	Td:	xīu lǐ
	033	D:	((点头))
	034	Td:	老王修理,修理,后边
	035	D:	(4.0)
	036	Td:	后边是什么
	037	Td:	还没完呢这句话,老王修理,
	038		(1.2)
	039	Td:	修理什么
	040	D:	汽车
	041	Td:	汽车,对好,重复一遍
→	042	D:	老王车海边
	043	Td:	不对,不对,不对,又错了,再来一次
	044		(3.0)
	045	D:	老王
	046	Td:	嗯
→	047	D:	汽车(.)修理
	048	Td:	嗯,不对,不对,再重新来一遍
	049	D:	(2.0)老王
	050	Td:	嗯
→	051	D:	汽车(.)修理
→→	052	Td:	噢,不对,你看,老王修理汽车
	053	D:	老王修理汽车
	054	Td:	哎对,这样才通顺,老王干了个什么事儿,谁干了
	055		个什么事儿
	056	D:	((点头))

本段会话中,康复师的目的是让患者输出语法结构完整的句子。因此针对发音错误,康复师直接给出正确发音,两次正确纠音无果后,没有像语料 1 中康复师那样,逐步引导患者发出正确的读音,而是纠正患者的语法输出。针对语法错误阻碍源,康复师先采用重新设计话轮的方式引发改错。第 20 行,康复师用“把它组成一句话”引导 D 纠错失败后,在 22 行用“把它组合成一句通顺的

中国知网 https://www.cnki.net

话”重新发起纠正。但由于言语障碍,患者没能自己完成改错。康复师 34-39 行对上一话轮继续延展引导患者自我改错。D 修改失败后(31 行),康复师继续通过部分句子结构“老王修理”提示患者(34 行),患者没有给出应答(35 行),话轮间停顿 4 秒,36-39 行康复师继续引导患者自我改错,患者回应“汽车”(40 行),康复师对此进行了确认(41 行)。因为本段会话的目的不是找词,而是让患者有能力输出一个完整的语法结构,康复师要求患者重复一遍整个句子(41 行)。结果患者在重复时再次出现语法错误(42 行)。康复师在 43、48 和 52 行三次通过“不对”指出错误,等待患者在下个话轮提供出正确答案,但因患者纠错能力有限,下个话轮出现新的阻碍源,康复师给出了完整的语法结构(52 行),患者重复(53 行),纠错序列结束。

通过分析以上语料可见,康复师在处理中度和重度失语患者的会话时采取不同策略。对于重度失语患者,康复师更注重语言(如语义和语音)的准确性,避免直接提供目标词汇,导致纠错序列显著延长,正确表达在超过 120 个话轮后才出现。康复师在会话中监测患者表达、引导患者完成正确表达,以及在引导失败时提供目标话语。同时,康复师采用“部分语法结构”和“嵌入式纠错”等策略应对阻碍源,并在患者因会话压力表现出消极情绪(如叹气)时,通过共情及时缓解情绪压力(R. Wynn & M. Wynn 2006: 1389)。这些延长的纠错序列体现了康复会话中语言训练与情绪关怀的双重目标。对于中度失语患者,纠错序列相对较短,正确表达在 55 个话轮后出现。这一差异主要源于两方面:1)中度患者语言能力相对保留较好,语言输出和理解的准确性较高;2)康复师在处理会话错误时更加侧重语法修正,忽略发音错误,从而减少修正话轮的数量。此外,中度患者在会话中表现出的负面情绪较少,这可能与其承受的会话压力较轻有关。这表明,康复师在康复过程中需要根据患者能力调整策略,特别是在重度失语患者中,应减少会话压力以减轻负面情绪,同时将患者情绪管理作为未来康复会话的关注点(Yang *et al.* 2022: 40)。

2.2 家属与失语症患者会话中的纠错序列

表 2 列出了家庭会话中的会话错误及其处理详情,表中字母 F 代表家人,P 代表患者。

表 2 显示,家庭会话中家属主要处理患者的语义错误,纠错由家属发起并由家属或患者完成。家庭会话的纠错序列包括三种结构:1)最小后扩展纠错序列;2)内扩展纠错序列;3)多话轮纠错序列。家庭场景的纠错多发生在下一个话轮,方式更直接,目的是达成互通互解而非语言准确性。尽管家庭会话和康复会话均包含多话轮序列,但家属更常使用非严肃性话语(Barnes 2016: 118; Yang *et al.* 2023),且家庭会话的纠错不以患者输出正确话语为目的。

表 2. 家庭会话中的纠错序列

患者	失语程度	错误类型(次数)	纠错发起人(次数)	纠错完成人(次数)
A	重度	语音(1);语义(8)	F (49)	F(9);P(0)
B	重度	语音(2);语义(16)	F (81)	F(18);P(0)
C	中度	语义(13)	F (29)	F(6);P(7)
D	中度	语音(1);语义(7)	F (21)	F(2);P(6)

2.2.1 最小后扩展纠错序列

最小后扩展序列是指最小相邻对后出现一个单一话轮的最小回应,也作“序列结束第三位置”(sequence-closing third)(Schegloff 2007:118)。

在日常会话中,我们常看到像语料 3 这种纠错方式,听话者在话轮结束后纠正说话者话轮错误(极少一部分在话轮中纠正),符合 Schegloff *et al.* (1977: 362-378)指出的自我修正优先于他人修正原则。

语料 3　螺母

→　092　N:　他把螺丝拿走了
→→　093　Np:　螺母
　　094　N:　对,把螺母拿走了

但我们对失语症患者在日常生活中与家属的会话考察发现,家属纠错一般发生在话轮结束之前。一般会话错误出现后,家属立即纠正,家属纠正后患者重复正确答案,纠错序列结束。错误话轮与纠错话轮组成一个最小相邻对,患者重复或确认构成一个最小应答这种序列结构表现为最小后扩展序列,如图 1 所示:

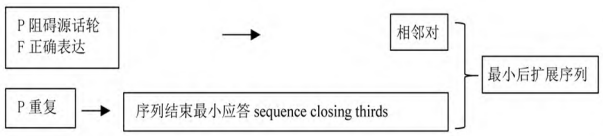

图 1. 最小后扩展纠错序列(P 代表患者,F 代表家属)

这种纠错结构中,即使当前说话方话轮未结束,家属也会进入阻碍源话轮直接在修正话轮提供正确表达,纠错方式直接简短,会话纠错速度快。如在以下语料 4 中,家属 Bs 与患者 B 正在讨论泉水,当患者描述泉水中的乌龟很可爱时,由于

中国知网　https://www.cnki.net

失语症导致的找词障碍误把乌龟讲成“王八”，虽然两者语义接近，但“王八”属于粗俗语，不适宜日常表达，家属因此在 190 行进入患者话轮，直接提供正确表达“小乌龟”，修改得到患者确认后，会话继续。

语料 4　小王八

	187	B：	能去，以前去过，以前去过，以后，它也：在那个泉水
	188		也冒泡泡，，它有那个不光是冒泡泡，还有，里边儿
→	189		还有那个，能看到一个小-小的王八=
→→	190	Bs：	=小乌龟
	194	B：	小乌龟，小王八在咱那个泉水里玩儿，也挺好

同样在语料 5 的最小后扩展纠错序列发生在父亲 Cd 纠正患者话轮中的阻碍源“第二饭”，在话轮未结束时，父亲进去话轮，提供了正确表达“中午饭”，患者在下个话轮重复中午饭，最小后扩展纠错序列结束。

语料 5　第二饭

	056	C：	呃，/deyi/，在医院里，哎也是，在-在医院里躺着，
	057		早晨吃饭，吃个鸡蛋，呃：：咸菜什么的，第二-第二
→	058		饭就是自己=
→→	059	Cd：	=中午饭
	060	C：	中午饭，他们就可以给盘子什么的，再给你做饭，

2.2.2 内扩展纠错序列

内扩展序列是指发生在最小相邻对第一话轮和第二话轮之间的会话序列（Schegloff 2007：50）。

在内扩展纠错序列结构中，当会话错误出现时，家属不直接纠错，而是通过重复错误源的方式引发患者自己纠正。这种纠错结构表现为：患者会话中出错，家属重复错误反问患者，患者回应，之后自我纠错，家属确认，如图 2 所示：

P 阻碍源话轮

F 重复错误
P 自我纠错 } 内扩展序列

F 确认

图 2. 内扩展纠错序列（P 代表患者，F 代表家属）

语料 6 为患者刚起床，家属 Bf 向患者 B 问好，患者回应家属早上好时，错讲成“早饭好”，属于语义错误，但由于早饭好这种表达的突兀，使其成为一个笑点。家属 35 行笑着重复错误源“早饭好”反问，发起纠正后，患者下个话轮用“笑”回应，并紧接着给出了正确表达“早上好”。家属在 37 行用最小应答“对”确认。

语料 6　早饭好

	033	Bf：	早上好
	034	B：	诶，早饭好
→	035	Bf：	早饭好？
			((笑))
→→	036	B：	((笑)) 早上好
	037	Bf：	对

同样语料 7 中家属 Dw 问患者摁电梯摁几楼，患者 D 回答“摁 5”，而实际楼层为 15，家属 273 行重复错误源“摁 5”，并通过选择疑问形式给出正确选项“还是 15 啊”，患者 274 行回应“笑”随即自我纠正为“15”。家属 275 行确认修正结果。

语料 7　摁 5

	271	Dw：	咱摁电梯的时候咱摁几
	272	D：	摁 5
→	273	Dw：	摁 5 啊是 15 啊
→→	274	D：	((笑)) 15
	275	Dw：	就是

语料 8 为家属 Aw 和患者 A 在剪指甲时发生的家庭会话，133 行会话中家属问患者手里的剪指刀是什么东西，134 行患者回应“剪子”，会话错误出现。135 行家属重复错误源“剪子”，反问“这叫剪子啊”，136 行患者回应“不叫”，意识到自己的错误，随即修改成“剪指刀”。137 行家属确认修正结果。

语料 8　剪子

	133	Aw：	这叫什么东西啊
	134	A：	/nnn/剪子
→	135	Aw：	剪子．这叫剪子啊
→→	136	A：	不叫．剪指刀
	137	Aw：	嗯

上述语料片段（6-8）中的纠错序列相较于最小后扩展纠错序列多出一个内部扩展序列，内扩展序列一般以家属发起纠错和患者意识到错误为最小句对（语料 6 35-36；语料 7 273-274；语料 8 135-136）。首先，患者可以通过言语方式表达自己意识到错误如“不叫”（语料 8），也可以通过非言语形式如笑声（语料 6）表达意识到错误。通过笑声表达自己对会话错误的意识是失语症患者交际能力的体现（Wilkinson 2019：287；Holt & Glenn 2013：77-83）。其次，患者在上述会话中均成功完成了自我纠正，这说明家属对于患者的语言能力掌握较好，可以根据患者语言能力恰当选取纠正策略。对于患者不熟悉的或经过提示意识不到的错误，家属一般直接纠错，这些纠错方式体现在最小后扩展纠错序列中；对于患者经过提示可以意识到的错误，家属一般选择提示的方式让患者自己完成修改，这种改错方式体现在内扩展纠错序

中国知网　https://www.cnki.net

列中。相比康复会话,家庭会话中也会出现较长的纠错序列,但占比非常小,且会话中对于引导患者表达完整正确内容的策略和方式与康复会话略有不同,语料 8 较为典型地呈现了此类差异特征。

2.2.3 多话轮纠错序列

多话轮后扩展序列是指最小相邻对第二话轮后出现新的会话序列组织(Schegloff 2007:48-50)。在这种序列结构中,最小相邻对被多次后扩展,形成多话轮纠错序列结构。

语料 9　毛豆

	001	Dw:	这是啥
			((指自己的头发))
	002	D:	毛豆
→	003	Dw:	哈?
	004	D:	<毛豆>
→	005	Dw:	毛豆?
	006	D:	嗯
→	007	Dw:	你家的头发是毛豆呀
	008	D:	((笑))
→	009	Dw:	哈?
	010		(2.0)
→	011	Dw:	你家的-拿这毛豆煮煮吃了去吧
	013	D:	((笑))

这段对话发生在患者 D 与家属 Dw 在家闲聊中,妻子 Dw 指着自己的头发问 D“这是啥”,D 回答毛豆,会话错误出现,整个会话变成纠错序列。第 3 行 Dw 采用开放式修正发起方式“哈?”,D 重复错误答案“毛豆”,说明此时 D 仍没意识到答案的错误。第 5 行 Dw 采用重复方式进一步发起修正“毛豆?”,第 6 行 D 确认,此时 D 仍没意识到答案的错误,第 7 行家属 Dw 继续升级修正方式“你家的头发是毛豆呀”,患者第 8 行用笑声回应。这里家属在第 7 行采用了一种非严肃话语的形式发起修正。患者只回应了话语的非严肃部分,没有回应其严肃部分,即给出修正结果。会话在 13 行结束。

这种多话轮纠错序列与语料 1 和语料 2 康复会话中的纠错序列有相似之处,如它们都是多话轮引发患者自我纠错导致的会话序列延长,但也有两点不同:其一,纠错序列结束的标志不同。康复师在患者不能完成自我纠错后会给出正确答案,且要求患者重复答案,康复会话中的纠错序列才结束;而在家庭会话中家属一般不追究正确答案(如语料 8),在一些语料中,纠错序列以家属给出正确答案为标志结束纠错序列。其二,纠错序列的长度不同,在康复会话中,纠错序列长度可达上百个话轮才能结束;在家庭会话中,纠错序列较短,一般十几个话轮即可结束。

3. 总结与展望

本文探讨了言语康复师和家庭成员在处理失语症患者的语言错误时的方式,研究发现会话中纠错序列是两种情境下常见的语言错误处理方式。然而,由于康复会话和家庭会话具有不同的任务和特点,纠错序列在这两种情境下亦各有差异。具体来说:

1)家庭会话中,他人纠错优先于失语症患者自我纠错,而康复会话中自我纠错仍然占据主导。

2)家庭会话中的纠错方式更加多样,包括多话轮纠错序列、最小后扩展纠错和内扩展纠错结构。而康复会话中,多话轮纠错序列较为常见。康复会话中的纠错序列通常更长,序列扩张更为明显。平均而言,康复场景中每个错误需要 16 个话轮来进行纠正,而家庭场景中仅需要 4 个话轮。康复会话的多话轮纠错序列容易触发患者的消极情绪。

3)在多话轮纠错序列中,康复师在采用阻碍源应对策略多次提示患者,而没得到正确回应后,一般通过部分语法结构或者话轮增补引导患者进行自我纠错,而家属则倾向于以非严肃话语的方式,这种方式通常会引发患者笑声,增加患者会话参与度,有助于缓和多次修正无解的会话氛围,提升患者的交际能力。

临床上言语康复(即重建患者的语言能力)是言语障碍的最终目的,失语症的干预治疗也基本服务于这一目的。不同于其他言语障碍如构音或吞咽障碍,可以通过手术、药物治疗或者语音训练结合等方式实现康复,失语症的临床疗法还是以会话为主,增强型和替代性通讯装置(AAC)(这些装置装有预先编程的语句、图像和声音,患者可以通过触摸屏幕或使用其他输入方式来进行沟通)为辅。这种疗法决定了失语症的康复是一个复杂艰难的过程,西方已经转变干预目的,从失语症的言语康复转变为言语提升(Better Conversation with Aphasia, BCA)(详情参考伦敦学院大学言语提升实验室 https://www.ucl.ac.uk/pals/research/language-and-cognition/language-and-cognition-research/better-conversations-lab)。该观点认为失语症患者应更多的参与会话,实现日常沟通。会话达成互解频次增高即达到了干预目的。

纠错是会话中错误处理的常见方式。在汉语康复会话中,康复师处理错误时倾向于保留正确答案,通过一系列提示来引导患者自行纠正错误。

中国知网　https://www.cnki.net

这种纠错方式强调患者的言语障碍,并对障碍进行针对性的训练,一定程度上提高了患者的语言准确性。但这种训练方式所取得的效果在实际会话中的应用微乎甚微。一般来讲,通过大量的训练来弥补语言能力不足是课堂上常见的言语训练做法(Koshik 2002: 277-280)。然而,失语症患者因脑损伤丧失了部分记忆和学习能力,与言语能力正常但有限的人群有着根本不同。因此,失语症的康复路径更复杂。鉴于这种情况,我们有理由考虑转变干预方式;而上述对家庭会话的考察发现,家属多利用患者的语言能力,补充其能力不足的部分(比如面对患者会话错误,直接或者提示无果后给出正确表达),这对于患者积极参与会话,提高其日常交流能力有积极作用,或许可以为失语症患者会话提供新的康复契机。

此外,传统失语症评估主要以失语症患者的临床测试表现为参考,常见的测试量表有西方失语症测试(Kertesz 1982: 37-41)及波士顿失语症检测表(Goodglass & Kaplan 1983: 77),但这些量表都以测试性语料为出发点评估失语症患者语言能力,忽略其日常会话中的实际交流能力,Holland(1977: 168)已证实失语症患者实际交流能力高于其参与测试所展现出的能力。本研究可以为评估失语症患者的实际交流能力提供借鉴。

综上,本研究为失语症患者的康复提供了新的思考。研究首次将家庭会话纳入失语症会话的干预考量,为上门医疗言语康复服务提供借鉴。我国政府近年来系统推进语言康复服务体系建设,通过制定专项政策规划、加大财政投入力度、完善专业机构网络布局等措施,着力构建失语症人群语言康复服务体系,持续提升语言康复服务的可及性与专业化水平。基于本研究的发现,未来,政府及医疗卫生部门可以进一步改进、提升个性化失语症康复服务,以更好地满足患者的需求,提高他们的语言功能。同时,政府及医疗卫生部门可以通过教育和培训家庭成员,使他们能够更好地支持失语症患者,促进患者的社交和语言能力的提升,帮助提高失语症患者的生活质量,更好地融入社会。

参考文献

[1] Barnes, S. Aphasia and open format other-initiation of repair: solving complex trouble in conversation[J]. *Research on Language and Social Interaction*, 2016(2): 111-127.

[2] Beeke, S., Capindale, S. & L. Cockayne. Correction and turn completion as collaborative repair strategies in conversations following Wernicke's aphasia[J]. *Clinical Linguistics & Phonetics*, 2020(10-11): 933-953.

[3] Bolden, G. B. Hepburn, A., Potter, J., Zhan, K., Wei, W., Park, H. S. & L. Mikesell. Over-exposed self-correction: Practices for managing competence and morality[J]. *Research on Language and Social Interaction*, 2022(3): 203-221.

[4] Goodglass, H. & E. Kaplan. *Boston Diagnostic Aphasia Test*[M]. Philadelphia: Lea and Febiger, 1983.

[5] Holland, A. L. Some practical considerations in the treatment of aphasic patients[A]. In M. Sullivan & M. Kommers(eds.). *Rationale for Adult Aphasia Therapy*[C]. Omaha, NE: University of Nebraska Press, 1977: 167-180.

[6] Holt, E. & P. Glenn. *Studies of Laughter in Interaction*[C]. London: Bloomsbury Publishing, 2013.

[7] Jefferson, G. Glossary of transcript symbols with an introduction[A]. In G. H. Lerner(ed.). *Conversation Analysis: Studies from the First Generation Amsterdam*[C]. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2004: 13-31.

[8] Kertesz, A. *Western Aphasia Battery*[M]. New York: Grune & Stratton, 1982.

[9] Koshik, I. Designedly incomplete utterances: A pedagogical practice for eliciting knowledge displays in error correction sequences[J]. *Research on Language and Social Interaction*, 2002(3): 277-309.

[10] Laakso, M. & M. L. Sorjonen. Cut-off or particle: Devices for initiating self-repair in conversation[J]. *Journal of Pragmatics*, 2010(4): 1151-1172.

[11] Laakso, M. Collaborative participation in aphasic word searching: Comparison between significant others and speech and language therapists[J]. *Aphasiology*, 2015(3): 269-290.

[12] Lesser, R. & L. Algar. Towards combining the cognitive neuropsychological and the pragmatic in aphasia therapy[J]. *Neuropsychological Rehabilitation*, 1995(1-2): 67-92.

[13] Lock, S., Wilkinson, R., Bryan, K., Maxim, J., Edmundson, A., Bruce, C. & D. Moir. Supporting partners of people with aphasia in relationships and conversation (SPPARC)[J]. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 2001(1): 25-30.

[14] Lubinski, R., Duuchan, J. & B. Weitzner-Lin. Analysis of breakdown and repairs in aphsic adult communication[A]. In R. Brrokshire(ed.). *Clinical Aphasiology Conference Proceedings*[C]. Minneapolis: BRK, 1980: 111-116.

[15] Oelschlaeger, M. L. & J. S. Damico. Word searches in aphasia: A study of the collaborative responses of communicative partners[A]. In C. Goodwin (ed.). *Conversation and Brain Damage*[C]. Oxford: Oxford University Press, 2003: 211-230.

[16] Schegloff, E. A., Jefferson, G. & H. Sacks. The preference for self-correction in the organization of repair in conversation[J]. *Language*, 1977(2): 361-382.

[17] Schegloff, E. A. *Sequence Organization in Interaction*[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

[18] Wilkinson, R., Beeke, S. & J. Maxim. Adapting to

中国知网 https://www.cnki.net

conversation: On the use of linguistic resources by speakers with fluent aphasia in the construction of turns at talk[A]. In C. Goodwin(ed.). *Conversation and Brain Damage*[C]. Oxford: Oxford University Press, 2003: 59-89.

[19] Wilkinson, R. Intervening with conversation analysis in speech and language therapy: Improving aphasic conversation [J]. *Research on Language and Social Interaction*, 2014(3): 219-238.

[20] Wilkinson, R. Atypical interaction: Conversation analysis and communicative impairments[J]. *Research on Language and Social Interaction*, 2019(3): 281-299.

[21] Wynn, R. & M. Wynn. Empathy as an interactionally achieved phenomenon in psychotherapy: Characteristics of some conversational resources[J]. *Journal of Pragmatics*, 2006(9): 1385-1397.

[22] Yang, X. X., Ma, W. & R. Wilkinson. Turn initial aiya as a response in interactions with Mandarin speakers of aphasia[Z]. Presented at the Atypical Interaction Conference. Newcastle, UK, 2022.

[23] Yang, X. X., Ma, W. & R. Wilkinson. Non-seriou speech as a repair-based strategy in everyday talks invovling Mandarin speakers of aphasia[Z]. Presented at the International Conference on Conversation Analysis. Brisbane, Australia, 2023.

[24] 马　文,高　迎.汉语医患会话中同话轮内自我修正研究[J].外国语,2018(3):42-54.

[25] 谭淑文,马　文.失语症患者交流中的"阻碍源"应对策略的会话分析研究[J].外语教学,2022(5):15-22.

基金项目:本文系国家社科基金重点项目"面向认知障碍相关脑疾病的中国临床话语分析理论体系构建研究"(项目编号:22AZD155)的阶段性研究成果。

作者简介:杨信信,谢菲尔德大学健康科学学院人类交流学系博士研究生,研究方向:会话分析、言语障碍。

马文,山东大学外国语学院应用会话分析研究所教授,博士生导师,研究方向:临床语言学、会话分析。

责任编校　**周永平**

欢迎赐稿　欢迎订阅《外语教学》

《外语教学》(双月刊)由西安外国语大学主办,系中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、北京大学中文核心期刊(语言文字类)、中国国际影响力学术期刊、中国人文社科学报核心期刊、中国人文社会科学综合评价(AMI)核心期刊、RCCSE 中国核心学术期刊、中国科技核心期刊(社会科学卷)、全国百强社科学报、全国高校精品社科期刊、陕西省权威社科期刊,国内外公开发行。

本刊以繁荣学术、促进中国的外语教学与研究为己任,主要设有语言学与语言研究、外语教学与研究、外语教育改革与发展研究、外国文学评论、翻译研究、翻译与国际传播等栏目。本刊根据国家语言战略与外语教育改革发展需要,不定期设置特约专栏和专家特稿,力争交流与传播学术界最新研究成果。

本刊按国际学术界通行做法实行同行专家双向匿名审稿制度,来稿正文请勿显示作者任何个人信息,以免影响稿件的审理;来稿请另页附上稿件题目、作者姓名、署名单位、职称学历、研究方向、基金项目、联系电话、电子邮箱、通讯地址等信息。

本刊倡导学术创新,反对学术造假、抄袭、剽窃、过度重复、一稿两投等学术不端行为。本刊将使用中国知网学术不端文献检测系统对来稿进行检测,文字重复率超过 15%的稿件将退回作者重新修改再投。请作者投稿时一定注意查重,来稿文责自负,编辑部对拟用稿件有修改权,不同意修改者请在来稿时说明。

稿件格式要求和规范请参见已出版的各期杂志,也可登录中国知网查看本刊,或请登录本刊网站:

http://xwxb.xisu.edu.cn/,浏览我刊投稿须知、格式体例、近期目录等。

本刊现为 112 页,大 16 开本,每期定价为 20 元,全年 120 元。本刊逢单月 10 日出版,全国各地邮局征订发行,邮发代号 52-170,如果错过征订也可直接与编辑部联系。

联系地址:710061 西安市长安南路 437 号西安外国语大学 62 号信箱学报编辑部

电　话:(029)85309400　　电子邮件:xisuxb@163.com　　本刊网站:http://xwxb.xisu.edu.cn/

中国知网　https://www.cnki.net